

Redesenho do fluxo de análise dos benefícios por incapacidade na Perícia Médica Federal: revisão de evidências sobre triagem documental, teleperícia e alocação de capacidade

Gustavo M. Mendes de Tarso

2026

SUMÁRIO

1	Identificação	1
2	Questão e escopo da revisão	2
3	Protocolo de busca	2
3.1	Blocos e consultas executadas	2
3.2	Critérios de inclusão	3
3.3	Critérios de exclusão	4
4	Registro por fonte	4
5	Fluxo de seleção	6
6	Situação da triagem	6
7	Nota metodológica	6

1 IDENTIFICAÇÃO

- Perfil: relatorio_prisma_busca_orientada_fgv.
- Etapa: busca e triagem pendente.
- Layout institucional: paper_{fgv}.
- Projeto: prisma_{fluxopmf}.

2 QUESTÃO E ESCOPO DA REVISÃO

- Tema: Redesenho baseado em evidências do fluxo de análise dos benefícios por incapacidade na Perícia Médica Federal
- Recorte: Brasil; organização do fluxo entre análise documental, teleperícia, perícia presencial, capacidade ordinária e mutirões. O ATESTMED é tomado como referência institucional de análise documental, sem restringir a busca à experiência brasileira.
- Objetivo: Analisar evidências e alternativas para redesenhar o tratamento de requerimentos por incapacidade, combinando análise documental, avaliação remota, perícia presencial, capacidade territorial e critérios auditáveis de alocação.
- Pergunta de pesquisa: Como estruturar um fluxo de alocação de requerimentos entre análise documental, teleperícia e perícia presencial que reduza o tempo de espera sem comprometer a qualidade decisória, a equidade territorial e o controle?
- Tipo de estudo: revisão estruturada de evidências para análise e redesenho de política pública

3 PROTOCOLO DE BUSCA

- Estratégia: blocos_tematicos.

3.1 Blocos e consultas executadas

- Benefícios por incapacidade e avaliação médico-pericial: disability benefits AND medical assessment
- Benefícios por incapacidade e avaliação médico-pericial: incapacity benefit AND medical evaluation
- Benefícios por incapacidade e avaliação médico-pericial: work disability AND medical certification
- Análise documental e elegibilidade: documentary assessment AND disability
- Análise documental e elegibilidade: medical certificate AND disability benefits
- Análise documental e elegibilidade: medical documentation AND work incapacity
- Teleperícia e avaliação remota: remote medical assessment AND disability
- Teleperícia e avaliação remota: telemedicine AND disability assessment
- Teleperícia e avaliação remota: telehealth AND medical certification
- Capacidade, filas e alocação de serviços: disability benefits AND waiting time

- Capacidade, filas e alocação de serviços: medical assessment AND service capacity
- Capacidade, filas e alocação de serviços: case allocation AND disability services
- Equidade territorial, qualidade e controle: disability assessment AND equity of access
- Equidade territorial, qualidade e controle: remote assessment AND quality assurance
- Equidade territorial, qualidade e controle: medical certification AND audit
- Palavras-chave: benefícios por incapacidade; disability benefits assessment; análise documental de incapacidade; documentary review disability claims; teleperícia; telemedicine disability evaluation; perícia médica presencial; triagem de requerimentos por incapacidade; work capacity assessment; gestão de filas em saúde; equidade territorial no acesso; auditabilidade de decisões administrativas
- Idiomas: português; inglês; espanhol
- Bases selecionadas: Crossref; OpenAlex; Semantic Scholar; Scopus; Web of Science; PubMed/NCBI; Europe PMC; SciELO; CORE

3.2 Critérios de inclusão

- Estudos que analisem benefícios por incapacidade, afastamento por doença, seguro por incapacidade, certificação médica ou avaliação médico-pericial.
- Estudos que abordem triagem documental, elegibilidade, análise de documentos médicos, validação de atestados ou processos de decisão sobre incapacidade.
- Estudos que examinem teleperícia, telemedicina aplicada à avaliação, avaliação médica remota, videoperícia ou modalidades híbridas de avaliação.
- Estudos que analisem capacidade operacional, filas, tempo de espera, produtividade, priorização de casos, alocação de profissionais ou gestão de demanda em serviços periciais ou sistemas de benefícios.
- Estudos que discutam acesso territorial, equidade, barreiras geográficas, inclusão de populações remotas ou desigualdades de acesso à avaliação médico-pericial.
- Estudos que tratem de qualidade decisória, confiabilidade, auditoria, controle, integridade, prevenção de fraude, revisão de decisões ou riscos associados à avaliação remota ou documental.
- Estudos empíricos, avaliações de política pública, estudos de caso institucionais, revisões sistemáticas, revisões de escopo ou relatórios técnicos com evidência útil para a pergunta de pesquisa.

- Publicações em português, inglês ou espanhol.

3.3 Critérios de exclusão

- Telemedicina exclusivamente assistencial, sem relação substantiva com avaliação de incapacidade, certificação, elegibilidade, triagem ou gestão de fluxos.
- Estudos clínicos que não contribuam para compreender processos de avaliação médico-pericial, decisão administrativa, capacidade, acesso, qualidade ou controle.
- Textos sem relação substantiva com a pergunta de pesquisa ou com ao menos um eixo da matriz analítica.
- Editorial, comentário, notícia, apresentação, resumo de congresso ou opinião sem análise, dados, revisão ou contribuição institucional verificável.
- Duplicidades entre bases ou consultas.
- Registros sem título, resumo ou metadados suficientes para triagem humana.
- Publicações em idioma diferente de português, inglês ou espanhol quando não houver informação suficiente para avaliação confiável.

4 REGISTRO POR FONTE

Base	Registros recuperados	Situação
Crossref	300	ok
OpenAlex	300	ok
Semantic Scholar	200	parcial
Scopus	15	ok
Web of Science	0	não executada: credencial ausente
PubMed/NCBI	289	ok
Europe PMC	300	ok
SciELO	0	bloqueada por anti-automação
CORE	255	parcial

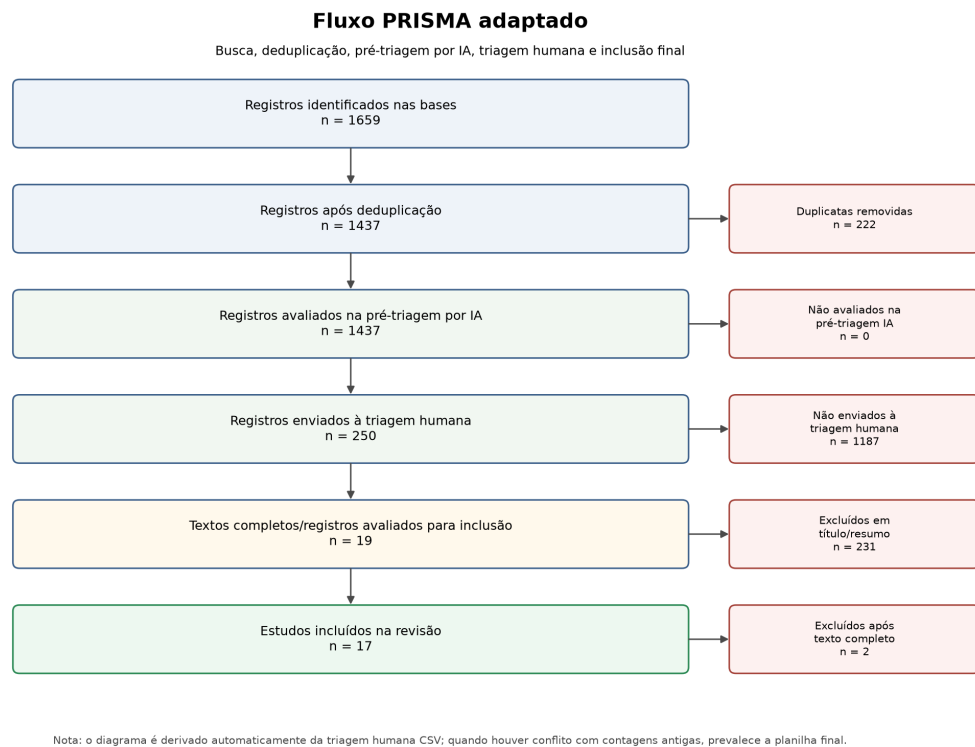


Figura 1 – Diagrama PRISMA adaptado ao fluxo de busca, pré-triagem por IA e triagem humana.

5 FLUXO DE SELEÇÃO

Etapa	Quantidade
registros identificados	1659
duplicatas removidas	222
registros apos deduplicacao	1437
registros pre triagem ia avaliados	1437
registros enviados para triagem	250
triagem titulo resumo concluida	250
registros excluidos titulo resumo	231
textos completos avaliados	19
textos completos excluidos	2
estudos incluidos	17
registros na planilha	250

A figura apresenta o funil de seleção da revisão. As contagens finais de triagem humana são derivadas do arquivo `triagem_humana.csv`; quando contagens intermediárias antigas entram em conflito com a planilha final, prevalece a reconciliação pela decisão humana final.

6 SITUAÇÃO DA TRIAGEM

A busca foi concluída, mas a inclusão e a exclusão de estudos permanecem pendentes de decisão humana na planilha de triagem.

- A planilha foi ordenada por pré-triagem assistida por IA antes do limite inicial de registros.
- A recomendação e a justificativa da IA servem apenas para priorização; elas não substituem a decisão humana.
- Planilha de triagem: `/home/gustavodetarso/Documentos/mppg/software/academic_pipeline`
- Após preencher a planilha, importe-a com `--prisma-importar-triagem`. O pipeline então produzirá a versão final deste relatório no mesmo layout e com a mesma engine PDF configurada no TOML.

7 NOTA METODOLÓGICA

Este documento registra a estratégia de descoberta e a situação da triagem. Ele não apresenta a busca como revisão concluída nem substitui a avaliação humana dos títulos, resumos e textos completos.